

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5016649-09.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: DENAIR TEODORO DOS SANTOS

MEDIDA DE URGÊNCIA. PACIENTE ONCOLÓGICO. PRAZO DA LEI 12.732/2012 ULTRAPASSADO. ATENDIMENTO PRIORITÁRIO. NOTÓRIA GRAVIDADE DA ENFERMIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5016649-09.2025.4.02.5101

510015660813 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5016649-09.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: DENAIR TEODORO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de medida recursal interposta pela União Federal em face da decisão de evento 5, DESPADEC1 dos autos originários que deferiu a tutela de urgência para determinar que os Réus providenciem à autora consulta em cirurgia plástica - tumor de pele, com o subsequente tratamento oncológico adequado.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão combatida, alegando, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC; violação ao princípio da isonomia; impossibilidade de custeio de procedimentos em unidade privada de saúde; além do necessário direcionamento ao ente federativo administrativamente competente.

Contrarrazões de evento 7, CONTRAZ1.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Diante da ausência de novos elementos, colaciono os termos da decisão de evento 3, cuja fundamentação mantenho através do presente voto:

"Sabe-se que a norma do artigo 196 da Constituição da República, outorga verdadeiro direito subjetivo a todas as pessoas que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizar o indigitado comando constitucional, garantindo aos cidadãos o acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A saúde é um direito fundamental do ser humano e configura consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana, que constitui fundamento basilar de nosso Estado Republicano.

Pois bem. Para fins de concessão da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC elenca dois pressupostos que devem estar cumulativamente presentes no caso concreto, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora.

Em juízo perfunctório, verifica-se a presença dos requisitos supracitados, haja vista que os documentos dos autos originários comprovam que a recorrida recebeu diagnóstico de lesões em face sugestivas de CARCINOMA BASOCELULAR, encontrando-se em fila para atendimento oncológico e cirurgia plástica desde 07/05/2024 (evento 31, PARECER1), com **risco vermelho - emergência**.

Ou seja, em muito já se passou o prazo legal para que a autora desse início ao tratamento que comprovadamente necessita, pois a Lei nº 12.732/2012, que dispõe sobre o tratamento de paciente com neoplasia maligna, estabelece o prazo 60 (sessenta) dias contado do dia em que foi firmado o primeiro diagnóstico:

Art. 1º O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta **Lei**.

Parágrafo único. A padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e republicada, e atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados.

Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

Por esses fundamentos, não se mostra razoável que a autora aguarde em fila de espera ou por um provimento jurisdicional em cognição exauriente, não havendo o que se falar em violação ao princípio da isonomia, já que os pacientes oncológicos possuem o privilégio legal de serem atendidos com máxima celeridade diante da própria natureza da doença acometida, que in casu, enseja risco de óbito (evento 1, DOC1).

Ademais, a competência para a tutela do direito fundamental à saúde é solidária entre todos os entes federados, conforme entendimento pacífico do Pretório Excelso, de modo que eventuais atos infralegais que estabeleçam atribuições administrativas distintas aos referidos entes não podem se sobrepor ao entendimento do STF, nem ao que dispõe a Carta Magna.

Por fim, embora a decisão a quo não tenha mencionado, em caso de ausência de vagas na rede pública é plenamente possível que a consulta e o início do tratamento ocorram na rede privada em convênio com o SUS, direito esse já reconhecido pelo STJ, veja-se:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM LEITOS E UTI DE HOSPITAIS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM REDE PARTICULAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA FALTA DE LEITO NA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico e garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. (...) 5. **A jurisprudência consolidada do STJ entende que não viola legislação federal a decisão que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em leitos e UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado.** 6. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1803426 RN 2019/0081442-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019).

Portanto, o recurso interposto pela União possui natureza meramente protelatória, uma vez que estão claramente presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme acima explanado, além da inequívoca mora do Poder Público, devendo ser mantida integralmente a decisão a quo."

Ou seja, pela análise dos autos do processo originário, verifico a presença cumulativa dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC.

Reitero que a autora foi diagnosticada com lesões em face sugestivas de CARCINOMA BASOCELULAR, encontrando-se em fila para atendimento oncológico e cirurgia plástica desde 07/05/2024, com **risco vermelho - emergência**. Ou seja, já foi ultrapassado o prazo legal (Lei nº 12.732/2012) para que a autora desse início ao tratamento que comprovadamente necessita, estando o Poder Público em mora.

No mais, diante da notória gravidade do quadro clínico não é possível que a autora aguarde indefinidamente em fila de espera, considerando-se também sua idade avançada (94 anos) e a própria natureza da enfermidade que pode levar a paciente a óbito. Como fundamentado na decisão monocrática retro, não há violação ao princípio da isonomia na medida em que os pacientes oncológicos gozam de um privilégio de serem atendidos com prioridade no prazo legalmente fixado.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** à medida de urgência apresentada, na forma da fundamentação supra. Sem condenação em custas e honorários. Uma vez referendada pela Sexta Turma Recursal, intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juizado de origem.

5016649-09.2025.4.02.5101

510015660762 .V2